ICS 11.020
C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.17—2009

针灸技术操作规范　第17部分：鼻针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—Part 17：Nose acupuncture

2009-02-06 发布　　2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为21个部分：

——第1部分：艾灸；

——第2部分：头针；

——第3部分：耳针；

——第4部分：三棱针；

——第5部分：拔罐；

——第6部分：穴位注射；

——第7部分：皮肤针；

——第8部分：皮内针；

——第9部分：穴位敷贴；

——第10部分：穴位埋线；

——第11部分：电针；

——第12部分：火针；

——第13部分：芒针；

——第14部分：锓针；

——第15部分：眼针；

——第16部分：腹针；

——第17部分：鼻针；

——第18部分：口唇针；

——第19部分：腕踝针；

——第20部分：毫针基本刺法；

——第21部分：毫针针刺手法。

本部分为GB/T 21709的第17部分。

本部分的附录A为规范性附录，附录B、附录C为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分起草单位：湖北中医学院。

本部分起草人：吴绪平、陈邦国、梁凤霞、杨毅红、王述菊、杜艳军、唐宏图、黄伟。

针灸技术操作规范　第17部分:鼻针

1　范围

GB/T 21709的本部分规定了鼻针的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项及禁忌。

本部分适用于鼻针技术操作。

2　术语和定义

下列术语和定义适用于GB/T 21709的本部分。

2.1

鼻针　nose acupuncture

在鼻部范围内的特定穴位上施以针刺,用以治疗疾病的方法。

3　操作步骤与要求

3.1　施术前准备

3.1.1　针具选择

选用直径0.22 mm～0.28 mm、长15 mm～25 mm毫针,所选针具针身应光滑、无锈蚀,针尖应锐利、无倒钩,针柄应牢固、无松动。

3.1.2　部位选择

根据病情在鼻部选取相应的穴位,在穴区内寻找敏感点。鼻针穴位名称、定位见附录A中的A.1,鼻针穴位定位示意图见图A.1所示。鼻部敏感点的寻找方法参见附录B。

3.1.3　体位选择

选择患者舒适、医者便于操作的体位,以仰卧位为宜。

3.1.4　环境要求

应注意环境清洁卫生,避免污染。

3.1.5　消毒

3.1.5.1　针具消毒:应选择高压消毒法。宜选择一次性毫针。

3.1.5.2　部位消毒:用75%乙醇或0.5%碘伏的棉球在施术部位消毒。强刺激部位宜用0.5%碘伏棉球消毒。

3.1.5.3　术者消毒:医者双手应用肥皂水清洗干净,再用75%乙醇棉球擦拭。

3.2　施术方法

3.2.1　进针

根据穴位所在部位,采用斜刺或平刺,快速刺入所选定的穴位,针刺深度视具体部位而定,以2 mm～5 mm为宜。

3.2.2　行针与留针

捻转要轻,待患者有酸、麻、胀、痛或流泪、打喷嚏等针感时,留针10 min～30 min。

3.2.3　出针

出针时快速将针拔出。

3.3　施术后处理

用消毒干棉球或干棉签按压针孔。

4 治疗间隔时间及适应证

4.1 鼻针治疗间隔时间参见附录 C 的第 C.1 章。

4.2 鼻针适应证参见附录 C 的第 C.2 章。

5 注意事项

5.1 由于鼻部肌肉较薄，鼻区皮肤比较敏感，刺激宜轻，避免进针过深以及强烈提插、捻转。

5.2 孕妇慎用。

5.3 鼻部有瘢痕时针刺应避开。

5.4 防止晕针的发生。如发生晕针现象，处理方法参见附录 C 的第 C.3 章。

5.5 患者精神紧张、大汗后、劳累后或饥饿时不适宜运用本疗法。

6 禁忌

6.1 鼻部皮肤局部有感染、溃疡、创伤者禁针。

6.2 有出血倾向者禁针。

6.3 金属过敏者禁针。

附　录　A
（规范性附录）
鼻针穴位名称、定位及分布示意图

A.1　鼻针穴位名称及定位

鼻针穴位共23个，分布在以下3条线上：

a）　面中线（第一线）：起于前额正中，止于水沟穴之上，共9个穴位，分别是：

1）　头面：额正中处，眉心与前发际中点连线的上、中1/3交点处；

2）　咽喉：头面与肺之间，当眉心与前发际中点连线的中、下1/3交点处；

3）　肺：两眉头连线之中点；

4）　心：两目内眦连线之中点；

5）　肝：当鼻梁最高处，鼻正中线与两颧骨连线之交点处；

6）　脾：当鼻准头上缘正中线上；

7）　肾：在鼻尖端处；

8）　前阴：在鼻中隔下端尽处；

9）　睾丸、卵巢：在鼻尖肾点的两侧。

b）　鼻孔线（第二线）：起于目内眦下方，紧靠鼻梁骨两侧，至鼻翼下端尽处止，共5个穴位，分别是：

1）　胆：位于肝区的外侧，目内眦下方；

2）　胃：位于脾区的外侧，胆区直下方；

3）　小肠：在鼻翼上1/3处，胃点下方；

4）　大肠：在鼻翼正中处，小肠点下方；

5）　膀胱：在鼻翼壁尽处，大肠点下方。

c）　鼻旁线（第三线）：起于眉内侧，沿鼻孔线的外方，止于鼻翼尽端外侧，共9个穴位，分别是：

1）　耳：在眉内侧端，与肺相平；

2）　胸：在眉棱骨下，目窠之上；

3）　乳：在睛明穴之上方；

4）　项背：在睛明穴之下方；

5）　腰脊：在胆区之外，项背点外下方；

6）　上肢：在胃区之外方，腰脊点外下方；

7）　胯股：在鼻翼上部相平处外侧，上肢点外下方；

8）　膝胫：在鼻翼正中外侧，胯股点下方；

9）　足趾：在鼻翼下部相平处外侧，膝胫的下方。

A.2　鼻针穴位定位示意图

鼻针穴位定位示意图见图A.1。

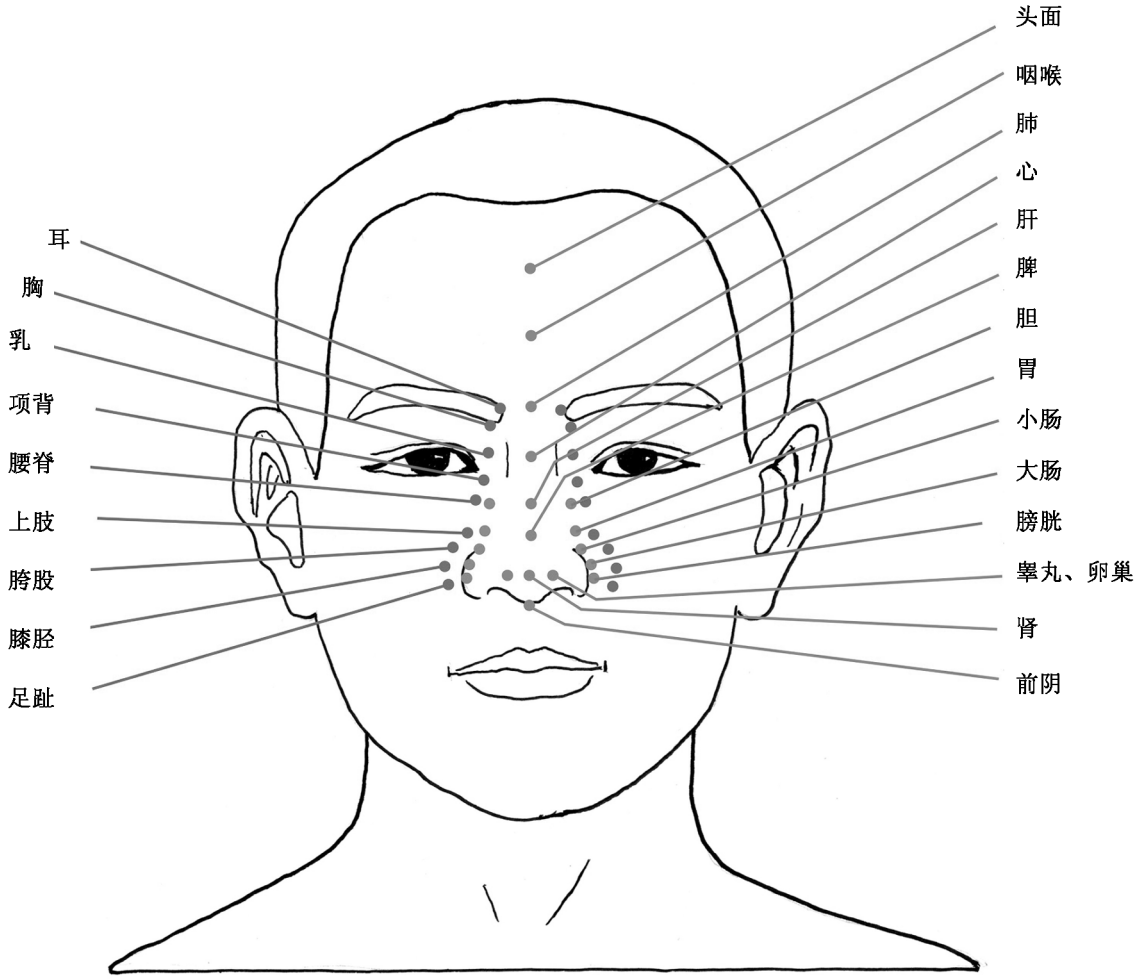

图 A.1　鼻针穴位分布示意图

附　录　B
（资料性附录）
鼻部敏感点的寻找方法

用探棒在鼻部的相应区域内，轻、慢、均匀地用一定压力探测，遇有疼痛或异常感时即为敏感点；或用干棉球擦干鼻部湿润区域，用电阻探测仪在患者鼻部的病变相应部位做缓慢、均匀的探查，患者感到局部有明显压痛，探测仪亦发出声响，此点即为敏感点。

附　录　C
（资料性附录）
鼻针治疗间隔时间、适应证及晕针的处理方法

C.1　鼻针治疗间隔时间

鼻针治疗间隔时间根据病情需要而定，可每日1次或者隔日1次。

C.2　鼻针的适应证

鼻针穴位都是按人体器官名称命名，因此，穴位名称即主治相应器官疾病，如：

a）　内科疾病：支气管炎、高血压、胃炎、肠炎等。

b）　神经、精神科疾病：偏头痛、面神经麻痹等。

c）　骨伤及软组织疾病：落枕、肩周炎、腰肌劳损及各部位软组织损伤等。

d）　外科疾病：阑尾炎、胆囊炎等。

e）　男性科疾病：睾丸炎、前列腺炎等。

f）　妇科疾病：痛经、慢性盆腔炎等。

g）　五官科疾病：咽喉炎、鼻炎、牙痛、耳鸣等。

C.3　晕针的处理方法

若发生晕针应立即出针，使患者呈头低脚高卧位，注意保暖，必要时可饮用温开水或温糖水，或掐水沟、内关等穴，即可恢复。严重时按晕厥处理。